

1. L'insuffisance cardiaque congestive est caractérisée par une diminution de la contractilité myocardique.	1. Vrai
2. La forme aiguë de l'insuffisance cardiaque se caractérise par une dyspnée sévère et une orthopnée soudaine.	2. Vrai
3. La forme chronique de l'insuffisance cardiaque nécessite toujours une prise en charge urgente.	3. Faux
4. L'éthanol, la cocaïne et la chimiothérapie sont des toxiques qui peuvent causer une insuffisance cardiaque.	4. Vrai
5. Les déséquilibres électrolytiques ne sont pas une cause potentielle d'insuffisance cardiaque.	5. Faux
6. Les infections comme les myocardites ne peuvent pas conduire à une insuffisance cardiaque.	6. Faux
7. Les cardiomyopathies sont parfois réversibles.	7. Vrai
8. La cardiomyopathie alcoolique est une affection irréversible.	8. Faux
9. La cardiomyopathie du post-partum survient exclusivement dans les 6 mois suivant l'accouchement.	9. Faux
10. Le syndrome de Tako-Tsubo est caractérisé par une atteinte de la contractilité myocardique due à une ischémie coronarienne.	10. Faux
11. La tachycardiomyopathie est une cardiomyopathie dilatée consécutive à des tachyarythmies prolongées.	11. Vrai
12. Le remodelage ventriculaire ne se produit que dans l'insuffisance cardiaque diastolique.	12. Faux

13. Une réduction de la fraction d'éjection ventriculaire de 50% à 25 % entraîne toujours une diminution du volume éjecté systolique.	13. Faux
14. Le débit cardiaque est toujours insuffisant pour les besoins de l'organisme en cas d'insuffisance cardiaque.	14. Faux
15. L'insuffisance cardiaque entraîne une activation délétère du système rénine-angiotensine-aldostérone.	15. Vrai
16. L'insuffisance cardiaque congestive se manifeste par de la dyspnée, de l'asthénie et une perte hydro-sodée.	16. Faux
17. L'insuffisance cardiaque chronique n'empêche pas les activités quotidiennes normales du patient.	17. Vrai
18. On parle d'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservé si un débit cardiaque adéquat ne peut être atteint qu'au prix d'une élévation pathologique de la pression de remplissage auriculaire.	18. Faux
19. L'insuffisance cardiaque à FEVG diminuée peut être causée par un obstacle au remplissage du VG.	19. Vrai
20. La péricardite constrictive peut entraîner une insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique.	20. Vrai
21. La perte de masse myocardique consécutive à un infarctus ou à l'exposition à certains toxiques peut entraîner une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée.	21. Faux
22. L'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique est le plus souvent idiopathique.	22. Faux
23. Les causes les plus fréquentes d'insuffisance cardiaque sont : ischémique > idiopathique > HTA > valvulaire.	23. Faux
24. L'HTA et la sténose aortique augmentent le travail du VG et peuvent provoquer une insuffisance cardiaque.	24. Vrai

25. Une cardiopathie congénitale avec shunt gauche-droit peut entraîner une insuffisance cardiaque par la surcharge en volume du ventricule gauche.	25. Vrai
26. L'insuffisance mitrale ou aortique augmentent le volume du VG et peuvent provoquer une IC à FEVG réduite.	26. Vrai
27. Il n'existe pas de cas familiaux d'insuffisance cardiaque.	27. Faux
28. L'IC à FEVG réduite est un signe de plusieurs maladies inflammatoires systémiques (lupus, sclérodermie,...).	28. Vrai
29. Certains déficits nutritionnels peuvent provoquer une insuffisance cardiaque.	29. Vrai
30. Le diabète sucré n'est pas une cause métabolique d'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique.	30. Faux
31. Les traitements antirétroviraux ne sont pas associés aux insuffisances cardiaques toxiques.	31. Faux
32. La maladie de Duchenne et l'ataxie de Friedrich peuvent entraîner une insuffisance cardiaque à FEVG réduite.	32. Vrai
33. Le diagnostic d'IC avec dysfonction systolique peut être posé uniquement sur base des signes et symptômes.	33. Faux
34. La toxicité myocardique directe de l'alcool et de ses métabolites est indépendante de la dose ingérée.	34. Faux
35. On estime que la dose d'alcool nécessaire à provoquer une cardiomyopathie alcoolique est de 1 litre de vin ou 12 bières par jour pendant plus de 2 ans.	35. Faux
36. La cardiomyopathie alcoolique est potentiellement réversible après l'arrêt des boissons alcoolisées.	36. Vrai
37. La susceptibilité individuelle influence l'intensité de la toxicité myocardique de l'alcool.	37. Vrai

38. La toxicité myocardique de l'alcool est favorisée par une association avec l'HTA, le tabagisme ou un déficit en K ⁺ , Na ⁺ ou en sélénium.	38. Faux
39. Le cobalt retrouvé dans la bière pourrait jouer un rôle dans la cardiomyopathie alcoolique.	39. Vrai
40. La cardiopathie du post-partum est une affection relativement fréquente des femmes enceintes.	40. Faux
41. La cardiopathie du post-partum est une insuffisance cardiaque diastolique d'origine indéterminée.	41. Faux
42. La fonction ventriculaire gauche et les symptômes s'améliorent de façon importante dans les 6 mois du diagnostic pour la moitié des cas de cardiomyopathies du post-partum.	42. Vrai
43. 20% des cas de cardiomyopathies du post-partum décèdent ou nécessitent une transplantation cardiaque.	43. Vrai
44. La cardiomyopathie du post-partum peut survenir durant la grossesse.	44. Vrai
45. Le syndrome de Tako-Tsubo se caractérise par une hyperkinésie apicale du VG et une akinésie basale.	45. Faux
46. Le syndrome de Tako-Tsubo ou cardiomyopathie de stress est généralement irréversible.	46. Faux
47. Le syndrome de Tako-Tsubo est induit par un stress intense à cause d'une toxicité des catécholamines.	47. Vrai
48. La resinualisation normalise la fonction systolique ventriculaire en cas de tachycardiomyopathie.	48. Vrai
49. La myocardite virale est une cause réversible d'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique.	49. Vrai
50. La caractéristique anatomique principale de l'insuffisance cardiaque systolique est l'atrophie cardiaque.	50. Faux

51. Le volume d'éjection systolique diminue parfois moins que la fraction d'éjection en cas d'IC systolique.	51. Vrai
52. Seul le volume ventriculaire télédiastolique augmente suite au « remodelage » ventriculaire en cas d'IC.	52. Faux
53. La dilatation cardiaque vise à compenser la diminution de contractilité en cas d'IC à FEVG préservée.	53. Faux
54. La dilatation cardiaque augmente la tension pariétale (selon la loi de Laplace) en cas d'IC systolique.	54. Vrai
55. La dilatation ventriculaire affecte les valves cardiaques et aggrave la surcharge en volume du VG.	55. Vrai
56. On parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite si elle est <60%.	56. Faux
57. On parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée si elle est >50%.	57. Vrai
58. Les mécanismes du remodelage ventriculaire dans l'insuffisance cardiaque sont bien compris.	58. Faux
59. L'activation du système orthosympathique et du SRA n'ont qu'une action favorable à court terme en cas d'IC.	59. Vrai
60. L'ANP et le BNP sécrétés par les oreillettes et les ventricules provoquent une rétention hydro-sodée.	60. Faux
61. Un NT-BNP plasmatique normal a une bonne valeur prédictive négative pour exclure une IC.	61. Vrai
62. La FA, le vieillissement et l'insuffisance hépatique augmentent le NT-BNP.	62. Faux
63. L'obésité morbide augmente le NT-BNP.	63. Faux
64. Le remodelage ventriculaire de l'insuffisance cardiaque comporte un raccourcissement des myocytes et une instabilité myocytaire à cause de la dissolution du collagène qui solidarise les cellules contractiles.	64. Faux

65. Beaucoup de myocytes meurent par un processus d'apoptose et sont remplacés par de la fibrose au cours du remodelage ventriculaire de l'insuffisance cardiaque systolique.	65. Vrai
66. L'insuffisance cardiaque active la sécrétion d'ADH et de peptides natriurétiques.	66. Vrai
67. L'activation du système orthosympathique et du SRAA et l'ADH permettent à court terme d'augmenter la post-charge, de maintenir la PA et la perfusion cérébrale et d'augmenter la contractilité myocardique.	67. Faux
68. Les cathécholamines ont une toxicité myocardique directe à long terme et favorisent les arythmies.	68. Vrai
69. L'activation du système orthosympathique et du SRAA ont un effet défavorable à long terme en cas d'IC systolique : congestion pulmonaire, anasarque, augmentation de la consommation myocardique d'O ₂ ,...	69. Vrai
70. L'ANP et le BNP sont produits en réponse à une augmentation de la pression diastolique.	70. Vrai
71. L'ANP et le BNP sont produits en réponse à une diminution de la tension pariétale.	71. Faux
72. L'ANP et le BNP induisent une natriurèse, une diurèse et une vasoconstriction.	72. Faux
73. Le sacubitril favorise l'action de la néprilysine qui dégrade l'ANP et le BNP.	73. Faux
74. La détresse respiratoire est un symptôme fréquent de l'insuffisance cardiaque.	74. Vrai
75. La détresse respiratoire de l'IC est multifactorielle : œdème alvéolaire, spasme bronchique, hypoxémie,...	75. Faux
76. La dyspnée d'effort est classée selon la classification fonctionnelle NYHA.	76. Vrai

77. L'orthopnée est un symptôme rare avant la classe NYHA III.	77. Vrai
78. La dyspnée paroxystique nocturne est rapidement réversible en position verticale.	78. Faux
79. Le VES diminue souvent plus vite que la FEVG en cas d'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique.	79. Faux
80. La respiration de Cheyne-Stokes se caractérise par une alternance de périodes d'hyper- et d'hypoventilation.	80. Vrai
81. Les sujets de classe NYHA I sont asymptomatiques.	81. Faux
82. Le volume ventriculaire télésystolique augmente suite à la dilatation cardiaque en cas d'IC systolique.	82. Vrai
83. La fatigue est rarement associée à l'insuffisance cardiaque.	83. Faux
84. La nycturie est un symptôme urinaire classique de l'insuffisance cardiaque.	84. Vrai
85. Les sujets de classe NYHA IV sont symptomatiques même au repos.	85. Vrai
86. La dyspnée paroxystique nocturne est évaluée par le nombre de coussins utilisés pour dormir.	86. Faux
87. L'orthopnée est liée à la redistribution du volume vasculaire des jambes vers les poumons en décubitus.	87. Vrai
88. L'orthopnée est un signe très spécifique d'insuffisance cardiaque systolique.	88. Vrai
89. La dyspnée paroxystique nocturne se manifeste la nuit par une dyspnée aggravée, du wheezing et de la toux.	89. Vrai
90. La dyspnée paroxystique nocturne est une situation proche de l'œdème pulmonaire hémodynamique.	90. Vrai
91. La respiration de Cheyne-Stokes est la manifestation d'une pathologie d'origine pulmonaire.	91. Faux

92. La fatigue d'effort puis de repos est liée à la réduction de la tension artérielle en cas d'IC systolique.	92. Faux
93. La rétention hydro-sodée provoquée par l'insuffisance cardiaque peut entrainer une hyponatrémie.	93. Vrai
94. L'insuffisance cardiaque terminale se manifeste par une oligourie suite à une réduction de la perfusion rénale.	94. Vrai
95. L'insuffisance cardiaque peut se manifester par des symptômes digestifs induits par la surcharge volémique : hépatomégalie sensible, nausées, augmentation de l'appétit,...	95. Faux
96. Les symptômes cérébraux de l'IC sont très variables et liés à l'hypoxémie et à la réduction du débit cardiaque.	96. Vrai
97. L'hyperactivité orthosympathique se manifeste par une bradycardie.	97. Faux
98. Les bruits de galop (B3/B4) sont caractéristiques de l'insuffisance cardiaque.	98. Vrai
99. Il faut absolument une preuve objective de la dysfonction cardiaque pour établir le diagnostic d'IC.	99. Vrai
100. L'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique est le plus souvent d'origine ischémique.	100. Vrai
101. L'auscultation cardiaque ne permet pas de diagnostiquer l'insuffisance cardiaque.	101. Faux
102. L'échographie cardiaque permet de calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche.	102. Vrai
103. Une FEVG inférieure à 20% est un signe de pronostic vital très mauvais en cas d'insuffisance cardiaque.	103. Vrai
104. L'ergospirométrie est un examen couramment utilisé chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.	104. Vrai
105. Les râles de stase sont le plus souvent unilatéraux en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	105. Faux

106. Les râles de stase sont des râles humides expiratoires entendus aux bases pulmonaires qui signent la présence d'une congestion pulmonaire en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	106. Faux
107. L'insuffisance cardiaque systolique peut se manifester par des épanchements pleuraux.	107. Vrai
108. Les épanchements pleuraux liés au drainage lymphatique de l'excès de liquide alvéolaire se rencontrent exclusivement dans l'insuffisance cardiaque droite.	108. Faux
109. La disparition du murmure vésiculaire et une matité mobile sont des signes d'épanchement pleural.	109. Vrai
110. L'insuffisance cardiaque se manifeste par des signes de congestion systémique : ascite, OMI, hépatomégalie douloureuse, jugulaires dilatées, reflux hépato-jugulaire,...	110. Vrai
111. L'hyperactivité orthosympathique dans l'IC se manifeste par des mains moites, chaudes et rouges.	111. Faux
112. L'auscultation d'une insuffisance cardiaque systolique montre une atténuation du B1.	112. Faux
113. L'auscultation d'une IC systolique montre une augmentation de la composante pulmonaire du B2.	113. Vrai
114. L'auscultation d'une IC systolique montre un souffle de régurgitation mitral et/ou aortique.	114. Faux
115. Le pouls est rapide, filant et parfois alternant dans l'insuffisance cardiaque systolique.	115. Vrai
116. L'anémie ferriprive (déficit en fer) augmente le risque d'insuffisance cardiaque.	116. Vrai
117. L'hyperalbuminémie contribue aux œdèmes dans l'insuffisance cardiaque systolique.	117. Faux

118. L'étude de la viabilité myocardique n'est pas nécessaire dans l'insuffisance cardiaque.	118. Faux
119. L'auscultation ne montre jamais de bruits cardiaques supplémentaires en cas d'IC systolique.	119. Faux
120. La prise de sang est utilisée pour rechercher une hypernatrémie, un diabète, une insuffisance rénale ou une hypoalbuminémie en cas d'IC.	120. Faux
121. Le NT-proBNP peut être dosé à la biologie sanguine en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	121. Vrai
122. L'ECG d'une insuffisance cardiaque secondaire à un infarctus montre un microvoltage.	122. Vrai
123. L'échographie cardiaque n'est pas une technique utile pour mesurer les régurgitations valvulaires.	123. Faux
124. La radiographie de thorax montre une cardiomégalie et une congestion pulmonaire en cas d'IC.	124. Vrai
125. Une pathologie coronaire peut être détectée à l'ECG en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	125. Vrai
126. Une pathologie congestive hépatique ne montre aucun signes à la biologie sanguine.	126. Faux
127. Une VO2 à l'exercice maximal <50% de la valeur prédite révèle une altération fonctionnelle importante en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	127. Vrai
128. Le PET-scan n'est pas utilisé comme examen complémentaire en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	128. Faux
129. L'ECG est l'examen de choix pour choisir les candidats potentiels à une transplantation cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque congestive à dysfonction systolique.	129. Faux

130. L'étude de la viabilité myocardique peut se faire par scintigraphie myocardique, par échographie cardiaque avec perfusion de dobutamine et par résonance magnétique nucléaire.	130. Vrai
131. Une VO ₂ à l'exercice maximal <12 ml/kg/h révèle une altération fonctionnelle importante en cas d'IC.	131. Faux
132. Les épreuves d'effort comme l'ergospirométrie ne sont pas utilisés chez les insuffisants cardiaques.	132. Faux
133. Le PET-scan permet de rechercher des zones de myocarde ischémique viable susceptibles de bénéficier d'une intervention de revascularisation coronaire.	133. Vrai
134. La scintigraphie myocardique nécessite l'injection IV d'un produit de contraste iodé.	134. Faux
135. Une dysfonction thyroïdienne doit être recherchée en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	135. Vrai
136. Le traitement de l'insuffisance cardiaque systolique vise à prolonger la survie et à prévenir l'évolution vers une forme plus sévère mais ne permet pas d'améliorer les symptômes.	136. Faux
137. L'HTA et l'hypercholestérolémie doivent être strictement contrôlés en cas d'insuffisance cardiaque.	137. Vrai
138. Les bêta-bloquants et les antiagrégants sont recommandés après un infarctus myocardique.	138. Vrai
139. Le traitement pharmacologique est plus important que les mesures hygiéno-diététiques en cas d'IC.	139. Faux
140. La revalidation physique est recommandé pour corriger la pathologie musculaire périphérique en cas d'IC.	140. Vrai
141. Réduire la rétention volémique permet d'améliorer les symptômes de l'insuffisance cardiaque systolique.	141. Vrai

142. Aucun traitement ne peut améliorer l'altération du contrôle de la respiration associée à l'IC systolique.	142. Faux
143. Le sacubitril n'agit pas sur le remodelage ventriculaire dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.	143. Faux
144. Les IEC, les alpha-bloquants et la spironolactone permettent de prolonger la survie en cas d'IC systolique.	144. Faux
145. Un régime sans sel avec moins de 10g NaCl/jour est recommandé en cas d'insuffisance cardiaque.	145. Faux
146. Les apports hydriques d'un patient en insuffisance cardiaque ne doivent pas dépasser 1,5L/jour.	146. Vrai
147. Les diurétiques peuvent diminuer l'importance du régime hyposodé strict en cas d'IC légère ou modérée.	147. Vrai
148. L'insuffisance cardiaque systolique n'est jamais une indication à la transplantation cardiaque.	148. Faux
149. 50% des patients en insuffisance cardiaque décèdent subitement, souvent par fibrillation ventriculaire.	149. Vrai
150. Les bêta-bloquants permettent de réduire l'incidence de la fibrillation ventriculaire.	150. Vrai
151. Les IEC sont recommandés en prévention pour tous les patient en insuffisance cardiaque.	151. Faux
152. L'endothéline, l'aldostérone et l'AGII font partie des molécules qui favorisent la dysfonction et l'apoptose myocytaire ainsi que la fibrose interstitielle en cas d'insuffisance cardiaque.	152. Vrai
153. Les apports de NaCl doivent être réduits à 3-4g par jour en cas d'insuffisance cardiaque systolique sévère nécessitant de hautes doses de diurétiques.	153. Vrai
154. L'hyperactivation du SRAA et de la vasopressine en cas d'IC peuvent provoquer une hyponatrémie.	154. Vrai

155. L'hypernatrémie a une valeur pronostique négative en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	155. Faux
156. Certains cas d'IC doivent être traités par un défibrillateur implantable ou une revascularisation coronaire.	156. Vrai
157. La teneur corporelle en Na ⁺ diminue en cas d'IC systolique et la natrémie est souvent <130mEq/L.	157. Faux
158. L'alcool est à éviter dans tous les cas d'insuffisance cardiaque systolique.	158. Vrai
159. Il faut contrôler l'obésité et la diabète et lutter contre la cachexie et la carence en fer en cas d'IC.	159. Vrai
160. L'exercice physique améliore la dyspnée et les paramètres hémodynamiques en cas d'IC systolique.	160. Faux
161. Des exercices physiques dynamiques et résistifs à 90% de la consommation maximale en oxygène améliorent la tolérance à l'effort et la qualité de vie et apportent un bénéfice psychologique en cas d'IC.	161. Faux
162. L'exercice physique permet de réduire l'activation neuro-humorale en cas d'insuffisance cardiaque.	162. Vrai
163. L'augmentation du poids du patient en IC systolique est un signe d'aggravation de la congestion.	163. Vrai
164. Les diurétiques thiazidiques sont préférables en cas d'insuffisance cardiaque car ils restent efficaces jusqu'à une filtration glomérulaire très basse.	164. Faux
165. Les diurétiques de l'anse sont sécrétés activement dans les tubules rénaux.	165. Vrai
166. Les diurétiques de l'anse perdent leur efficacité quand la clearance de créatinine devient <30ml/min.	166. Faux
167. Les thiazides ont une action plus soudaine et moins prolongée que les diurétiques de l'anse.	167. Faux

168. Les diurétiques thiazidiques sont des meilleurs anti-hypertenseurs que les diurétiques de l'anse.	168. Vrai
169. Il faut préférer les diurétiques thiazidiques aux diurétiques de l'anse quand la rétention hydrosodée est sévère et la fonction rénale normale.	169. Faux
170. Les diurétiques thiazidiques perdent leur efficacité lorsque la clearance de créatine devient $<30\text{L/h}$.	170. Faux
171. Les diurétiques thiazidiques stimulent moins l'excrétion sodée que les diurétiques de l'anse.	171. Vrai
172. La résistance aux diurétiques peut s'expliquer par une biodisponibilité orale insuffisante du furosémide.	172. Vrai
173. Il est préférable de prescrire une seule dose journalière de diurétiques en cas d'IC systolique.	173. Faux
174. Les doses de diurétiques doivent être réduites en cas d'insuffisance rénale.	174. Faux
175. Les diurétiques de l'anse et les thiazides peuvent être associés si la réponse aux diurétiques est insuffisante.	175. Vrai
176. La dose de diurétiques doit être diminuée en cas d'hypoalbuminémie.	176. Faux
177. Un traitement inotrope positif intraveineux chronique par un agoniste bêta-adrénergique comme la dobutamine permet d'améliorer la perfusion rénale et d'augmenter l'effet des diurétiques.	177. Faux
178. Les diurétiques sont fortement liés aux protéines plasmatiques.	178. Vrai
179. Les diurétiques activent le SRAA et le système orthosympathique et doivent donc être inhibés par l'administration concomitante d'IEC et de bêta-bloquants en cas d'insuffisance cardiaque systolique.	179. Vrai

180.	L'hypoalbuminémie diminue l'effet des diurétiques chez le patient cachectique sous-alimenté.	180. Vrai
181.	Les diurétiques entraînent souvent une hypokaliémie et une hypermagnésémie.	181. Faux
182.	L'effet des diurétiques sur la kaliémie favorise les arythmies létales et réduit l'effet des digitaliques.	182. Faux
183.	La spironolactone a des effets myocardiques favorables à la dose de 25mg/h.	183. Faux
184.	L'adjonction de spironolactone est préférable aux suppléments de K ⁺ pour compenser l'hypokaliémie induite par les diurétiques en cas d'insuffisance cardiaque.	184. Vrai
185.	Les IEC inhibent complètement la production d'angiotensine II et d'aldostérone.	185. Faux
186.	Les antagonistes du récepteur à l'angiotensine peuvent être utilisés en cas d'intolérance aux IEC.	186. Vrai
187.	Le sacubitril est un antagoniste des récepteurs de l'AGII plus efficace qu'un IEC seul en cas d'IC.	187. Faux
188.	La spironolactone induit une gynécomastie chez 10% des hommes.	188. Vrai
189.	Les bêta-bloquants préviennent 50 % des morts subites chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.	189. Vrai
190.	Les bêta-bloquants doivent être débutés à haute dose en cas d'insuffisance cardiaque.	190. Faux
191.	Les bêta-bloquants doivent être administrés après que les inhibiteurs du SRAA et les diurétiques aient été introduits et que leur dose ait été optimisée et stabilisée.	191. Vrai
192.	Les diurétiques sont utilisés pour lutter contre la surcharge hydrosodée dans l'insuffisance cardiaque.	192. Vrai

193. Les diurétiques de l'anse sont préférés aux diurétiques thiazidiques chez les patients présentant une altération de la fonction rénale.	193. Vrai
194. Les thiazidiques ont une action moins soudaine et plus prolongée que les diurétiques de l'anse.	194. Vrai
195. Les diurétiques de l'anse sont de meilleurs antihypertenseurs que les diurétiques thiazidiques.	195. Faux
196. Les bêta-bloquants peuvent aggraver transitoirement l'insuffisance cardiaque chez certains patients	196. Vrai
197. Les bêta-bloquants peuvent être administrés même chez les patients asymptomatiques atteints d'IC.	197. Vrai
198. La digoxine réduit les hospitalisations pour aggravation de l'IC chez les patients en rythme sinusal.	198. Vrai
199. Les digitaliques ont un effet sur la mortalité chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.	199. Faux
200. Les digitaliques sont contre-indiqués chez les patients présentant une fonction rénale altérée.	200. Vrai
201. Les vasodilatateurs directs sont généralement préférés aux IEC dans le traitement de l'IC systolique.	201. Faux
202. La spironolactone est un antagoniste de l'angiotensine II.	202. Faux
203. La dobutamine est efficace pour améliorer transitoirement l'hémodynamique dans l'insuffisance cardiaque sévèrement décompensée.	203. Vrai
204. Les agents inotropes non digitaliques ont tendance à augmenter la mortalité en utilisation chronique.	204. Vrai
205. Les IEC augmentent la dégradation de la bradykinine.	205. Faux

206. Les bradykinines augmentent la production de NO et de prostaglandines à action vasodilatatrice et pro-mitotique.	206. Faux
207. Le NO et les prostaglandines pourrait médier une partie importante des effets bénéfiques des IEC.	207. Vrai
208. L'accumulation de bradykinine favorise la toux et l'angio-œdème lors de la prise d'IEC.	208. Vrai
209. Les IEC améliorent les symptômes mais n'augmentent pas la tolérance à l'effort en cas d'IC.	209. Faux
210. Les IEC n'ont pas d'effet bénéfique sur les patients asymptomatiques après un infarctus du VG.	210. Faux
211. Les IEC réduisent la mortalité totale des patients insuffisants cardiaque de 25%.	211. Vrai
212. Les IEC peuvent être administrés chez la femme enceinte à partir du 3 ^{ème} trimestre de grossesse.	212. Faux
213. Il est recommandé de traiter tous les patients insuffisants cardiaques par IEC si la FEVG est >40%.	213. Faux
214. Une pression artérielle systolique inférieure à 80mmHg est une contre-indication aux IEC en cas d'IC.	214. Faux
215. Une créatine sérique >3g/L nécessite une surveillance rapprochée en cas de traitement par IEC.	215. Vrai
216. La sténose bilatérale sévère des artères rénales et l'hypokaliémie sont des contre-indications aux IEC.	216. Faux
217. La toux est un effet indésirable du traitement par IEC observé chez 5 à 10% des patients.	217. Vrai
218. La toux ne nécessite jamais l'arrêt du traitement par IEC en cas d'insuffisance cardiaque.	218. Faux
219. Les IEC doivent être débutés à petite dose puis augmentés toutes les 1-2 semaines en cas d'IC.	219. Vrai

220.	Les sartans sont prescrits en 2 ^{ème} intention dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.	220. Vrai
221.	Les sartans induisent un blocage plus complet de l'angiotensine II que les IEC.	221. Vrai
222.	Les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine II provoquent aussi une accumulation de bradykinine.	222. Faux
223.	Le sacubitril-valsartan (Entresto®) est le traitement de 1 ^{er} choix en cas d'insuffisance cardiaque.	223. Vrai
224.	Le valsartan est un inhibiteur des récepteurs AT2 à l'angiotensine II.	224. Faux
225.	L'inhibition de la néprilysine par le sacubitril favorise l'accumulation de bradykinine et de peptides natriurétiques qui favorisent vasodilatation, réduction de l'effet orthosympathique et natriurèse/diurèse.	225. Vrai
226.	Le sacubitril-valsartan a un effet légèrement défavorable sur le remodelage cardiaque.	226. Faux
227.	Le sacubitril-valsartan permet de réduire la fibrose, l'hypertrophie cardiaque et le risque d'arythmies.	227. Vrai
228.	Le taux d'aldostérone est efficacement abaissée par les IEC en cas d'insuffisance cardiaque.	228. Faux
229.	La spironolactone peut remplacer les diurétiques de l'anse en cas d'effets secondaires importants.	229. Faux
230.	25mg/j de spironolactone réduisent la mortalité de 35% en cas d'IC sévère de classe III ou IV avec des dosées élevée des diurétiques de l'anse et d'IEC.	230. Vrai
231.	Les suppléments de K ⁺ sont à préférer à la spironolactone en cas d'hypokaliémie.	231. Faux
232.	Les bêta-bloquants luttent contre les effets orthosympathiques délétères dans l'insuffisance cardiaque.	232. Vrai

233. Les bêta-bloquants réduisent la mortalité de 50% si administré en plus des IEC et des diurétiques dans les cas d'insuffisance cardiaque de stade II, III ou IV stabilisée et sans surcharge volémique.	233. Faux
234. Les bêta-bloquants font partie du traitement aigue de l'insuffisance cardiaque décompensée.	234. Faux
235. L'asthme, le bloc auriculo-ventriculaire et la bradycardie sont des contre-indications aux bêta-bloquants.	235. Vrai
236. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'IC récente, déstabilisée ou réfractaire.	236. Vrai
237. Les bêta-bloquants induisent une aggravation transitoire de l'IC chez la majorité des patients.	237. Faux
238. Les bêta-bloquants doivent être débutés à très faibles doses puis augmentés toutes les semaines.	238. Faux
239. La dose à atteindre si possible est de 2x25mg/j pour le bisoprolol et 10mg/j pour le carvedilol.	239. Faux
240. Une aggravation transitoire de l'IC au début du traitement par bêta-bloquants nécessite une augmentation des diurétiques et des IEC et une diminution des bêta-bloquants ou des autres hypotenseurs.	240. Faux
241. Les bêta-bloquants sont préférables à l'ivabradine dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.	241. Vrai
242. L'ivabradine inhibe le canal If dans le nœud sinusal si le rythme sinusal reste >70 bpm.	242. Vrai
243. Les glifozines agissent au niveau du tubule distal.	243. Faux
244. Les glifozines sont efficaces dans le traitement de l'IC à FEVG réduite indépendamment de la présence du diabète de type 2.	244. Vrai

245. Les glifozines sont des inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2).	245. Vrai
246. Les inhibiteurs du SGLT2 réduisent les hospitalisation pour IC de 30% et les décès cardiovasculaires de 18% quand ils sont ajoutés à tous les autres traitements pharmacologiques et non pharmacologiques de l'IC.	246. Vrai
247. Les digitaliques sont des inhibiteurs de la Na-K-ATPase à action inotrope négative.	247. Faux
248. Les digitaliques augmentent la contractilité myocardique via une augmentation du Ca ²⁺ intracellulaire.	248. Vrai
249. Les digitaliques n'ont pas d'effet sur la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque.	249. Vrai
250. Les glycosides digitaliques réduisent les hospitalisations pour aggravation d'IC de 30% chez les patients en rythme sinusal.	250. Vrai
251. Les digitaliques sont moins efficaces quand la dysfonction cardiaque est très sévère.	251. Faux
252. Les digitaliques sont d'autant plus efficaces que le patient est symptomatique.	252. Vrai
253. Les digitaliques sont réservés aux insuffisants cardiaques qui restent symptomatiques en débit des IEC et des diurétiques.	253. Vrai
254. La digoxine à 25mg/j est utilisée pour ralentir la réponse ventriculaire en cas de fibrillation auriculaire.	254. Faux
255. La dose de digoxine doit être diminuée chez le sujet > 70 ans, obèse ou dont la fonction rénale est altérée.	255. Faux
256. La toxicité des digitaliques est favorisée par l'hypokaliémie et induit surtout des arythmies.	256. Vrai

257. La spironolactone, les IPP, beaucoup d'antiarythmiques et certains antibiotiques diminuent les taux plasmatiques de digoxine.	257. Faux
258. La cardioversion électrique est le traitement de choix pour les arythmies induites par les digitaliques.	258. Faux
259. Les anticorps anti-digoxine, la phénytoïne et la lidocaïne sont utilisées pour traiter les bradycardies induites par les digitaliques.	259. Faux
260. L'atropine est utile pour traiter les tachycardies ou la FV induites par les digitaliques.	260. Faux
261. La stimulation cardiaque externe temporaire est utile en cas de bradycardie induite par les digitaliques.	261. Vrai
262. Les vasodilatateurs directs sont un traitement de dernière intention en cas d'insuffisance cardiaque.	262. Vrai
263. L'hydralazine (vasodilatateur direct) associée à un dérivé nitré ou à l'amlodipine (antagoniste calcique) peut parfois être utilisée en cas d'angor ou d'HTA associée à l'insuffisance cardiaque.	263. Vrai
264. La dobutamine est un bêta-bloquant utilisé pour améliorer la contractilité myocardique dans l'IC aigue.	264. Faux
265. La dobutamine exerce un effet inotrope positif en augmentant le GMPc et le Ca ²⁺ intracellulaire.	265. Faux
266. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase III comme le milrinone augmente la contractilité myocardique.	266. Vrai
267. Le lévosimendan améliore la contraction en stabilisant le Ca ²⁺ sur la troponine.	267. Vrai
268. Un traitement anti-thrombotique n'est pas nécessaire dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.	268. Faux

269. Des agents activateurs de la myosine ou augmentant la sensibilité de la guanylate cyclase soluble au NO sont à l'étude pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.	269. Vrai
270. Une anticoagulation doit être prescrite en cas de FA, d'ATCD d'embolie ou de thrombus ventriculaire.	270. Vrai
271. Les anticoagulants oraux comme le dabigatran sont recommandés en cas de sténose mitrale modérée.	271. Faux
272. Les antivitamines K sont toujours préférables si le patient est porteur d'une valve mécanique.	272. Vrai
273. L'aspirine à haute dose est recommandée chez les insuffisants cardiaques qui ont de l'athérosclérose.	273. Faux
274. La resynchronisation ventriculaire est recommandée chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et présentant un bloc de branche gauche <130 ms.	274. Faux
275. Les gliflozines réduisent les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et les décès cardiovasculaires uniquement chez les patients diabétiques.	275. Faux
276. La FA chronique ou paroxystique est une indication d'anticoagulation en cas d'insuffisance cardiaque.	276. Vrai
277. La transplantation cardiaque est une option pour les insuffisants cardiaques dont l'espérance de vie est estimée à moins de 50 % dans les 2 ans avec une qualité de vie inacceptable.	277. Faux
278. L'assistance mécanique peut être utilisée comme traitement chirurgical en cas d'insuffisance cardiaque.	278. Vrai
279. L'aspirine à faible dose est recommandée chez les patients atteints d'IC et d'athérosclérose.	279. Vrai

280. La séquence d'administration des traitements les plus recommandés en cas d'IC à FEVG <40% est : diurétiques > IEC/sacubitril-valsartan > spironolactone > bêta-bloquants > glifozines.	280. Faux
281. De manière générale, le traitement de l'IC débute à petites doses et est progressivement augmenté pour atteindre les doses maximales tolérables ou recommandées.	281. Vrai
282. Les bêta-bloquants doivent être prescrits uniquement quand le patient est stabilisé en cas d'IC.	282. Vrai
283. Le resynchronisation ventriculaire est indiquée si le patient réunit 4 conditions : FEVG <35%, rythme sinusal, BBG > 130ms, symptômes persistants malgré le traitement.	283. Vrai
284. La resynchronisation ventriculaire vise à stimuler électriquement les ventricules en cas de BAV.	284. Faux
285. L'attraction du septum interventriculaire réduit l'efficacité de la contraction retardée du VG en cas de BBG.	285. Vrai
286. Un bloc de branche gauche suffisamment long peut indirectement impacter l'appareil sous-valvulaire mitral et aggraver une sténose mitrale.	286. Faux
287. La resynchronisation ventriculaire vise à stimuler électriquement les 2 ventricules en même temps.	287. Vrai
288. L'IC est un processus statique et isolé qui dépend peu d'autres facteurs physiologiques.	288. Faux
289. Les défibrillateurs implantables sont indiqués en cas d'insuffisance cardiaque uniquement en prévention secondaire d'une mort subite.	289. Faux

290. La prévention primaire de la mort subite concerne les patients symptomatiques (NYHA II-III) malgré les traitements avec une FEVG <35% et une cardiopathie ischémique survenue >40j après un infarctus.	290. Vrai
291. La prévention secondaire de la mort subite concerne les rescapés d'une arythmie ventriculaire avec instabilité hémodynamique survenue moins de 48h après un infarctus myocardique.	291. Faux
292. Une VO2 maximale <5ml/kg/min à l'exercice est une indication pour la transplantation cardiaque.	292. Faux
293. Une VO2 maximale <50% de la valeur prédite est une indication pour la transplantation cardiaque.	293. Vrai
294. La présence d'autres affections irréversibles significatives ou la mauvaise compliance thérapeutique sont des contre-indications à la transplantation cardiaque.	294. Vrai
295. Une insuffisance cardiaque compensée peut subitement s'aggraver à cause de la prise d'AINS.	295. Vrai
296. Les causes de décompensation cardiaque sont très nombreuses : ischémie myocardique, HTA non contrôlée, surinfection, hyper/hypothyroïdie, abus d'alcool, apports hydriques et sodés excessifs,...	296. Vrai
297. Les antagonistes calciques ne sont jamais responsables de décompensation cardiaque.	297. Faux
298. Une augmentation brutale de la pression de remplissage ventriculaire gauche peut entraîner une hypertension auriculaire gauche et artérielle pulmonaire.	298. Faux
299. La radiographie de thorax montre des stries de Kerley en cas d'œdème pulmonaire hémodynamique.	299. Vrai

300. Une fuite rapide de plasma à travers les capillaires pulmonaires vers les espaces interstitiels et les alvéoles se produit lorsque la pression télédiastolique ventriculaire gauche devient >10mmHg.	300. Faux
301. La clinique de l'OPH comprend généralement une détresse respiratoire sévère sans toux ni expectorations.	301. Faux
302. Tout traitement inotrope négatif est susceptible de provoquer la décompensation d'une IC contrôlée.	302. Vrai
303. L'auscultation montre des râles humides, des ronchis, du wheezing et des sibilances en cas d'OPH.	303. Vrai
304. L'œdème pulmonaire hémodynamique n'est pas visible à la radiographie de thorax.	304. Faux
305. Le traitement de l'OPH vise à améliorer rapidement les symptômes et à traiter le facteur déclenchant.	305. Vrai
306. L'administration d'oxygène est généralement évitée chez les patients atteints d'œdème pulmonaire hémodynamique pour prévenir une aggravation de l'état respiratoire.	306. Faux
307. Le furosémide per os est souvent utilisé dans le traitement de l'œdème pulmonaire hémodynamique.	307. Faux
308. L'œdème pulmonaire hémodynamique se manifeste par une bradypnée et une orthopnée.	308. Faux
309. Le patient atteint d'OPH crache souvent des expectorations mousseuses et rosées.	309. Vrai
310. Les dérivés nitrés peuvent être administrés par voie sublinguale ou intraveineuse en cas d'OPH.	310. Vrai
311. Tous les médicaments inotropes négatifs doivent être stoppés en cas d'OPH.	311. Vrai
312. Le patient est souvent cyanosé, anxieux et avec des signes de désaturation en cas d'OPH.	312. Vrai

313.	La dobutamine est un inotrope négatif utilisé dans le traitement de l'OPH pour augmenter la PAS.	313. Faux
314.	Tous les patients atteints d'œdème pulmonaire hémodynamique doivent être intubés.	314. Faux
315.	Le pronostic de l'œdème pulmonaire hémodynamique est meilleur si le patient est hypotendu.	315. Faux
316.	On administre de l'oxygène en cas d'OPH si la saturation est <80% ou si la PaO2 est <60mmHg.	316. Faux
317.	La ventilation non invasive est souvent recommandée comme traitement initial en cas d'OPH.	317. Vrai
318.	L'intubation trachéale et la ventilation assistée sont nécessaires en cas de détresse respiratoire sévère.	318. Vrai
319.	Le vérapamil est utilisé en cas d'œdème aigu du poumon pour améliorer la fonction cardiaque.	319. Faux
320.	Un suivi rapproché de l'ionogramme urinaire et de la diurèse est nécessaire en cas d'OPH.	320. Vrai
321.	On administre de l'oxygène dès que la saturation devient inférieure à 95% en cas d'OPH.	321. Faux
322.	Les diurétiques thiazidiques font partie du traitement de l'œdème pulmonaire hémodynamique.	322. Faux
323.	Les diurétiques de l'anse sont généralement préférés aux diurétiques thiazidiques chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque en raison de leur puissance et de leur action rapide.	323. Vrai
324.	La spironolactone peut induire une hyperkaliémie surtout en association avec un IEC ou un sartan.	324. Vrai
325.	L'hyponatrémie dans l'IC résulte de la rétention hydrosodée et de la sécrétion trop faible d'ADH.	325. Faux
326.	La norépinéphrine est contre-indiquée dans le traitement de l'œdème pulmonaire hémodynamique.	326. Faux

327. Le traitement initial de l'OPH est surtout composé d'O ₂ , de dérivés nitrés et de diurétiques de l'anse.	327. Vrai
328. Les inotropes positifs comme la dobutamine sont souvent utilisés pour augmenter la contractilité cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque aiguë en stimulant les récepteurs bêta-adrénergiques.	328. Vrai
329. Les inhibiteurs des SGLT2 sont efficaces même chez les insuffisants cardiaques sans diabète de type 2.	329. Vrai
330. La resynchronisation cardiaque peut être bénéfique en cas d'IC avec bloc de branche droit.	330. Faux
331. L'aspirine est un anti-agrégant plaquettaire recommandé en cas d'insuffisance cardiaque pour réduire le risque d'évènements cardiovasculaires.	331. Vrai
332. La transplantation cardiaque est indiquée si l'espérance de vie du patient atteint d'insuffisance cardiaque est inférieure à 50% endéans les 6 à 12 mois avec une qualité de vie inacceptable.	332. Vrai
333. L'assistance mécanique peut être utilisée en attendant la transplantation cardiaque en cas d'IC sévère.	333. Vrai
334. La dilatation des cavités cardiaques est un signe typique d'insuffisance cardiaque.	334. Vrai
335. L'œdème des membres supérieurs est un symptôme courant d'insuffisance cardiaque systolique.	335. Faux
336. L'IC peut entraîner une réduction de la perfusion tissulaire en raison d'une diminution du débit cardiaque.	336. Vrai
337. Les diurétiques sont utilisés pour augmenter l'excrétion d'eau et de potassium en cas d'IC.	337. Faux
338. Les diurétiques de l'anse sont préférables chez les patients avec une altération de la fonction rénale.	338. Vrai

339. L'utilisation prolongée de diurétiques peut entraîner une perte excessive de K ⁺ et de Mg ²⁺ et des troubles électrolytiques.	339. Vrai
340. L'IC avec FEVG préservée est caractérisée par une diminution de l'élasticité auriculaire gauche.	340. Faux
341. Le diagnostic de l'IC avec fonction systolique ventriculaire gauche préservée est souvent facile à établir.	341. Faux
342. On considère que la fonction systolique est préservée si la FEVG est >40%.	342. Faux
343. Un VG rigide ne peut être rempli qu'au prix d'une augmentation de pression dans l'oreillette gauche.	343. Vrai
344. Toutes les affections qui réduisent l'élasticité myocardique peuvent induire une dysfonction diastolique.	344. Vrai
345. L'augmentation de la séquestration diastolique du Ca ²⁺ dans le réticulum sarcoplasmique altère le processus actif de relaxation myocardique et induit une dysfonction diastolique.	345. Faux
346. L'insuffisance cardiaque à FEVG préservée est fréquente chez la femme âgée.	346. Vrai
347. L'IC à FEVG préservée entraîne une hypertension auriculaire gauche et veineuse pulmonaire.	347. Vrai
348. Le pronostic de l'IC à FEVG préservée est généralement meilleur que celui de l'IC à FEVG réduite.	348. Vrai
349. Le diagnostic de l'IC diastolique est posé grâce à l'échographie cardiaque et au dosage du NT-proANP.	349. Faux
350. La présentation clinique de l'IC est similaire peu importe si la FEVG est réduite ou préservée.	350. Vrai
351. Le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fonction préservée nécessite des examens complémentaires.	351. Vrai

352. La preuve objective d'une dysfonction diastolique doit être apportée par cathétérisme cardiaque.	352. Faux
353. Les causes d'IC à FEVG préservée sont très nombreuses : hypertrophie du VG suite à l'HTA ou à une sténose aortique, cardiopathie ischémique, cardiomyopathie hypertrophique, infiltrative ou restrictive,...	353. Vrai
354. La radiothérapie thoracique peut induire une cardiomyopathie hypertrophique.	354. Faux
355. L'amyloïdose, la tuberculose et l'hémochromatose peuvent entraîner une cardiomyopathie infiltrative.	355. Faux
356. La preuve objective d'une augmentation de la pression de remplissage du VG peut être apportée par l'échographie cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée.	356. Vrai
357. La FEVG est considérée comme préservée si elle est >60%.	357. Faux
358. Le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée consiste principalement à augmenter la surcharge volumique avec un régime hyposodé et des diurétiques et à traiter l'affection sous-jacente.	358. Faux
359. L'insuffisance cardiaque à FEVG préservée touche plus souvent les hommes que les femmes.	359. Faux
360. Le dosage du NT-proBNP contribue au diagnostic de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée.	360. Vrai
361. La dysfonction diastolique et la dysfonction systolique du VG sont souvent associés.	361. Vrai
362. Les patients atteints d'IC à FEVG préservée ne nécessitent aucun traitement médicamenteux.	362. Faux
363. L'ischémie myocardique peut entraîner une insuffisance cardiaque à dysfonction diastolique.	363. Vrai

364. La myocardite est toujours causée par des agents infectieux.	364. Faux
365. Le cytomégalo virus est rarement responsable d'une infection chronique chez les immunodéprimés.	365. Faux
366. La diphtérie est une cause fréquente de myocardite dans les pays développés.	366. Faux
367. <i>Corynebacterium diphtheriae</i> produit une substance toxique pour le myocarde responsable d'une cardiomyopathie dilatée et d'une polyneuropathie.	367. Vrai
368. La maladie de Lyme se manifeste principalement par une cardiomyopathie.	368. Faux
369. La maladie de Lyme provoquent des altérations de la conduction auriculo-ventriculaire.	369. Vrai
370. Le VIH peut induire une myocardite dans les stades précoces de la maladie.	370. Faux
371. La toxicité médicamenteuse, la dénutrition, la toxicomanie et les affections opportunistes pourraient jouer un rôle dans la myocardite liée au VIH.	371. Vrai
372. La maladie de Chagas est l'infection cardiaque virale la plus fréquente dans le monde.	372. Faux
373. La maladie de Chagas est principalement transmise par une piqûre de moustique en Europe.	373. Faux
374. Il n'existe pas de traitement médical curatif pour la cardiomyopathie liée à la maladie de Chagas.	374. Vrai
375. La cardiomyopathie liée à la maladie de Chagas récidive après la transplantation cardiaque.	375. Vrai
376. L'alcool et les anthracyclines sont des agents toxiques connus pour causer des myocardites.	376. Vrai

377. L'infection chronique à Trypanosoma Cruzi survient après une période de latence de quelques mois.	377. Faux
378. L'infection chronique à Trypanosoma Cruzi ne survient que chez 10 à 30% des patients.	378. Vrai
379. La myocardite auto-immunitaire survient après une affection bactérienne.	379. Faux
380. De très nombreux agents infectieux peuvent causer une myocardite : Coxsackie, influenza, adénovirus, fièvre Q, brucellose, toxoplasmose, leptospirose, rougeole, rubéole, aspergillose, méningocoque, chlamydia,...	380. Vrai
381. La myocardite se manifeste toujours par des symptômes évidents d'insuffisance cardiaque.	381. Faux
382. Les symptômes de la myocardite peuvent imiter ceux d'un infarctus du myocarde.	382. Vrai
383. La cardiomyopathie liée à la maladie de Chagas est caractérisée par une dilatation ventriculaire et des parois amincies par de la fibrose.	383. Vrai
384. La myocardite survient généralement plusieurs mois après une infection virale.	384. Faux
385. La myocardite subaiguë se caractérise par une douleur précordiale typique, des palpitations, une asthénie et une dyspnée à l'effort.	385. Faux
386. La myocardite se résout souvent dans les 4 à 12 semaines suivant l'apparition des symptômes.	386. Vrai
387. L'inflammation peut devenir chronique et provoquer une cardiomyopathie dilatée après une myocardite.	387. Vrai
388. La myocardite est souvent asymptomatique.	388. Vrai

389.	L'ECG montre généralement une bradycardie chez les patients atteints de myocardite.	389. Faux
390.	La conduction auriculo-ventriculaire ou intra-ventriculaire peut être altérée en cas de myocardite.	390. Vrai
391.	Les enzymes cardiaques sont généralement augmentées en cas de myocardite.	391. Vrai
392.	L'échographie cardiaque est généralement normale chez les patients atteints de myocardite.	392. Faux
393.	La biopsie endomyocardique est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic de myocardite.	393. Faux
394.	Les immunosuppresseurs sont toujours bénéfiques dans le traitement de la myocardite.	394. Faux
395.	Les patients atteints de myocardite peuvent reprendre une activité sportive dès le début du traitement.	395. Faux
396.	Le traitement de la myocardite repose uniquement sur la gestion des symptômes de l'IC congestive.	396. Faux
397.	L'ECG peut montrer des altérations du segment ST et de l'onde T en cas de myocardite.	397. Vrai
398.	La biologie montre généralement un syndrome inflammatoire en cas de myocardite.	398. Vrai
399.	L'arrêt de l'activité sportive est recommandé jusqu'à la normalisation de la FEVG en cas de myocardite.	399. Vrai
400.	Les immunosuppresseurs sont peuvent favoriser l'infection virale en cas de myocardite.	400. Vrai
401.	La cardiomyopathie hypertrophique est une affection génétique autosomique dominante.	401. Vrai
402.	Les mutations des gènes contrôlant les protéines du sarcomère sont responsables de la cardiomyopathie hypertrophique.	402. Vrai

403. Les cellules musculaires sont disposées de manière parallèle dans la cardiomyopathie hypertrophique.	403. Faux
404. Dans la cardiomyopathie hypertrophique, des cellules de taille variée alternent avec des zones de fibrose.	404. Vrai
405. La cardiomyopathie hypertrophique touche une personne sur 2000.	405. Faux
406. Les connections intercellulaires anormales entraînent des anomalies de la conduction électrique en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	406. Vrai
407. La cardiomyopathie hypertrophique affecte principalement les artères épigardiques.	407. Faux
408. La cardiomyopathie hypertrophique est l'affection génétique cardiaque la plus commune.	408. Vrai
409. Dans la cardiomyopathie hypertrophique, l'hypertrophie ventriculaire est toujours symétrique.	409. Faux
410. L'hypertrophie atteint surtout le septum interventriculaire en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	410. Vrai
411. La relaxation et la compliance ventriculaire sont augmentées en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	411. Faux
412. Les arythmies auriculaires ne sont pas associées à la cardiomyopathie hypertrophique.	412. Faux
413. Les lésions microvasculaires induisent une ischémie en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	413. Vrai
414. Les artères intra-myocardiques ont une média amincie et une lumière réduite en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	414. Faux
415. L'hypertrophie de la paroi réduit la cavité ventriculaire mais les ventricules restent hyperdynamiques.	415. Vrai

416. La fonction systolique n'est pas altérée en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	416. Vrai
417. Une hypertrophie ventriculaire marquée associée à une fonction systolique altérée doit faire suspecter une amyloïdose ou une maladie métabolique.	417. Vrai
418. La valve mitrale postérieure est attirée vers le septum en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	418. Faux
419. L'hypertrophie septale crée un obstacle à l'éjection du VG et induit un flux de haute vélocité vers l'aorte.	419. Vrai
420. Le mouvement anormal de la valve mitrale induit par la cardiomyopathie hypertrophique est favorisé par un allongement de la valve aortique et une insertion anormale des muscles papillaires.	420. Faux
421. La majorité des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique développent une obstruction intraventriculaire entre la chambre de chasse ventriculaire et l'aorte.	421. Faux
422. L'obstruction intraventriculaire n'est observé que à l'effort en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	422. Faux
423. La cardiomyopathie hypertrophique est souvent associée à une insuffisance mitrale.	423. Vrai
424. La valve mitrale antérieure est attirée vers le septum interventriculaire par un effet Venturi en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	424. Vrai
425. Le contact répété entre la valve mitrale et le septum interventriculaire peut induire une zone de fibrose.	425. Vrai
426. La fatigue musculaire périphérique est rarement associée à la cardiomyopathie hypertrophique.	426. Faux

427. La cardiomyopathie hypertrophique est généralement asymptomatique.	427. Vrai
428. Le septum interventriculaire hypertrophié crée un obstacle à l'éjection et provoque donc une augmentation de la pression intra-ventriculaire en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	428. Vrai
429. Les symptômes de la cardiomyopathie hypertrophique comprennent de l'asthénie, de la dyspnée, des palpitations, de l'angor et des syncopes.	429. Vrai
430. Un souffle para-sternal droit est souvent entendu en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	430. Faux
431. Le souffle de cardiomyopathie hypertrophique est aggravée par une augmentation du retour veineux.	431. Faux
432. La diminution de retour veineux diminue la taille du VG et aggrave l'obstruction intraventriculaire.	432. Vrai
433. Un souffle de régurgitation mitral est rarement associé à la cardiomyopathie hypertrophique.	433. Faux
434. La cardiomyopathie hypertrophique se manifeste par un souffle éjectionnel para-sternal gauche.	434. Vrai
435. La cardiomyopathie hypertrophique se manifeste par une diminution de l'amplitude des complexes QRS.	435. Faux
436. L'ECG montre une altération de la repolarisation en cas de cardiomyopathie hypertrophie.	436. Vrai
437. L'échographie cardiaque est peu utile dans le diagnostic de la cardiomyopathie hypertrophique.	437. Faux
438. Les potentiels tardifs sont recherchés par des ECG moyennés en cas de cardiopathie hypertrophique.	438. Vrai
439. Le cathétérisme cardiaque est souvent nécessaire pour diagnostiquer la cardiomyopathie hypertrophique.	439. Faux

440.	La scintigraphie montre de nombreux déficits de perfusion en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	440. Vrai
441.	L'ECG peut montrer une pseudo-onde Q de nécrose inférolatérale en cas de cardiopathie hypertrophique.	441. Vrai
442.	Un Holter du rythme cardiaque est inutile dans le suivi d'une cardiomyopathie hypertrophique.	442. Faux
443.	L'hypertrophie ventriculaire est plus sévère en cas d'HTA que de cardiomyopathie hypertrophique.	443. Faux
444.	Les potentiels tardifs sont des ondes de haute amplitude continuant le complexe QRS et se prolongeant 10ms dans le segment ST.	444. Faux
445.	Les ECG moyennés sont utiles pour évaluer le risque de tachycardie ventriculaire et de mort subite chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique.	445. Vrai
446.	La tachycardie ventriculaire non soutenue détectée par le Holter n'élève pas le risque de mort subite.	446. Faux
447.	L'hypertrophie ventriculaire est généralement concentrique chez le patient hypertendu.	447. Vrai
448.	La plupart des athlètes d'élite ont une hypertrophie ventriculaire prononcée.	448. Faux
449.	L'hypertrophie ventriculaire est moindre en cas de cardiomyopathie hypertrophique que chez les athlètes.	449. Faux
450.	Moins de 2% des athlètes d'élite ont un épaissement ventriculaire >13mm (N : 11mm).	450. Vrai
451.	L'ECG d'un athlète d'élite révèle une bradycardie sinusale, pas d'onde Q et pas d'altérations ST-T.	451. Vrai
452.	La fonction cardiaque diastolique est réduite par l'hypertrophie ventriculaire chez l'athlète d'élite.	452. Faux

453. La cardiomyopathie hypertrophique idiopathique du sujet >60 ans est moins sévère que la forme classique de la maladie mais se situe également dans le septum interventriculaire.	453. Vrai
454. Une angulation se forme entre l'aorte et les ventricules avec le vieillissement.	454. Vrai
455. La mort subite est une complication rare de la cardiomyopathie hypertrophique.	455. Faux
456. Les enfants et les jeunes atteints de cardiomyopathie hypertrophique sont plus à risque de mort subite.	456. Vrai
457. La fibrillation auriculaire est rarement associée à la cardiomyopathie hypertrophique.	457. Faux
458. Les embolies systémiques touchent 15% des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique par an.	458. Faux
459. L'examen familial est inutile dans la prise en charge de la cardiomyopathie hypertrophique.	459. Faux
460. La fibrillation auriculaire paroxystique ou persistante est traitée par cardioversion électrique ou par antiarythmiques K dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique.	460. Vrai
461. L'amiodarone augmente le risque de récurrence de FA en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	461. Faux
462. Les bêta-bloquants ou le diltiazem ralentissent la réponse ventriculaire à la fibrillation auriculaire.	462. Vrai
463. L'amiodarone est administrée chez tous les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique.	463. Faux
464. Les sports de compétition doivent être évités en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	464. Vrai
465. Les diurétiques peuvent aggraver l'obstruction en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	465. Vrai

466. Les défibrillateurs ventriculaires implantables sont indiqués en cas de tachycardie ventriculaire non soutenue ou de mort subite réanimée chez les patients atteint de cardiomyopathie hypertrophique.	466. Faux
467. Les bêta-bloquants sont utilisés pour la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive symptomatique.	467. Vrai
468. Les vasodilatateurs périphériques sont utilisés dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique.	468. Faux
469. Les vasodilatateurs atténuent l'effet Venturi qui attire la valve mitrale antérieure vers le septum interventriculaire hypertrophié en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	469. Faux
470. La vasodilatation périphérique aggrave le gradient de pression de part et d'autre de l'obstacle à l'éjection ventriculaire en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	470. Vrai
471. Une intervention chirurgicale (myomectomie inter-ventriculaire) est pratiquée dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique en cas d'échec du traitement pharmacologique.	471. Vrai
472. L'injection d'alcool dans une artère coronaire est utilisée pour créer un « infarctus expérimental ».	472. Vrai
473. Les bêta-bloquants ne sont pas utiles dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique.	473. Faux
474. La cardiomyopathie hypertrophique peut être traitée par l'injection d'alcool dans une des branches septales de l'artère inter-ventriculaire postérieure.	474. Faux
475. L'hypertrophie ventriculaire gauche est souvent asymétrique dans la cardiomyopathie hypertrophique.	475. Vrai

476. Les mutations affectant les protéines du sarcomère sont responsables de la cardiomyopathie dilatée.	476. Faux
477. Les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique ne présentent jamais de dyspnée.	477. Faux
478. La cardiomyopathie hypertrophique est principalement causée par des facteurs environnementaux.	478. Faux
479. L'auscultation d'une cardiomyopathie hypertrophique ne montre généralement pas de souffle cardiaque.	479. Faux
480. L'hypertrophie ventriculaire observée chez les athlètes d'élite est toujours pathologique.	480. Faux
481. La cardiomyopathie hypertrophique est rare chez les sujets de plus de 60 ans.	481. Faux
482. L'angor est provoqué par une augmentation de la pression intra-ventriculaire et des anomalies microvasculaires en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	482. Vrai
483. Les bêta-bloquants réduisent la dyspnée et l'angor en cas de cardiomyopathie hypertrophique.	483. Vrai
484. L'amiodarone est indiquée en cas de cardiomyopathie hypertrophique avec hypertrophie sévère.	484. Vrai
485. L'injection d'alcool dans une des branches septales de l'artère inter-ventriculaire antérieure est utilisée dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique en cas d'échec du traitement pharmacologique.	485. Vrai
486. L'amyloïdose, la sarcoïdose, l'hémochromatose, les métastases de mélanome ou de lymphome et certaines maladies métaboliques rares sont responsables de cardiomyopathie restrictive et infiltrative.	486. Vrai
487. Le signe de Küssmaul correspond à une augmentation de la turgescence jugulaire à l'inspiration.	487. Vrai

488.	La cardiomyopathie dilatée idiopathique est plus fréquente chez les sujets masculins et caucasiens.	488. Faux
489.	80% des péricardites aiguës sont causées par une infection virale.	489. Vrai
490.	La douleur thoracique dans la péricardite aiguë est réduite en position assise ou penchée en avant.	490. Vrai
491.	L'épanchement péricardique est perçu comme « le bruit de la neige écrasée sous les pas » à l'auscultation.	491. Faux
492.	L'ECG dans la péricardite aiguë montre initialement une élévation du segment PR.	492. Faux
493.	Les épanchements péricardiques légers même asymptomatiques doivent systématiquement être traités.	493. Faux
494.	Le drainage péricardique est toujours nécessaire en cas de tamponnade péricardique.	494. Vrai
495.	La constriction péricardique est souvent due à une inflammation aiguë.	495. Faux
496.	Le syndrome de Dressler peut survenir après une chirurgie cardiaque comportant une péricardiectomie.	496. Vrai
497.	La péricardite post-infarctus se manifeste généralement pendant la phase aiguë de l'infarctus.	497. Faux
498.	Le pouls paradoxal est un signe clinique caractéristique de la tamponnade péricardique.	498. Vrai
499.	L'ECG dans la constriction péricardique montre typiquement un sus-décalage du segment ST.	499. Faux
500.	La péricardite auto-immune peut survenir après un infarctus myocardique.	500. Vrai
501.	Le traitement de la péricardite aiguë implique toujours l'utilisation d'antibiotiques.	501. Faux
502.	Le signe de Küssmaul est caractéristique de la constriction péricardique.	502. Vrai

503.	Les corticoïdes sont souvent utilisés dans le traitement de la péricardite aiguë sévère.	503. Vrai
504.	Le syndrome de Dressler se caractérise par des douleurs articulaires.	504. Vrai
505.	La résonance magnétique nucléaire est l'examen de choix pour diagnostiquer la péricardite aiguë.	505. Faux
506.	Le traitement de la constriction péricardique implique généralement l'utilisation de diurétiques.	506. Vrai
507.	La tamponnade péricardique peut survenir même avec un épanchement lentement progressif.	507. Vrai
508.	L'élévation du segment ST est un signe typique de la péricardite aiguë à l'ECG.	508. Vrai
509.	Le traitement de la péricardite aiguë inclut souvent l'utilisation de colchicine pour prévenir les récives.	509. Vrai
510.	L'épanchement péricardique asymptomatique nécessite toujours un traitement.	510. Faux
511.	La présence d'un épanchement péricardique peut être détectée par l'échographie cardiaque.	511. Vrai
512.	La turgescence jugulaire est un signe clinique de la tamponnade péricardique.	512. Vrai
513.	Le traitement de la tamponnade péricardique implique généralement un drainage péricardique urgent.	513. Vrai
514.	La péricardite post-infarctus peut se manifester par une ré-élévation du segment ST dans la même région.	514. Vrai
515.	Le pouls paradoxal est un signe clinique de la péricardite aiguë.	515. Faux
516.	Le traitement de la constriction péricardique peut nécessiter une exérèse chirurgicale du péricarde.	516. Vrai
517.	L'épanchement péricardique peut être secondaire à une insuffisance cardiaque.	517. Vrai

518.	L'épanchement péricardique peut être détecté par la radiographie thoracique.	518. Vrai
519.	La présence de calcifications péricardiques à la radio thoracique est un signe de constriction péricardique.	519. Vrai
520.	La péricardite post-infarctus nécessite toujours l'arrêt de l'héparine.	520. Faux
521.	Le pouls paradoxal est un signe clinique de la constriction péricardique.	521. Vrai
522.	L'élévation du segment ST est un signe typique de la constriction péricardique à l'ECG.	522. Faux
523.	Le traitement de la péricardite aiguë implique toujours l'utilisation de diurétiques.	523. Faux
524.	L'épanchement péricardique peut être détecté par la résonance magnétique nucléaire.	524. Vrai
525.	Le péricarde normale est très élastique lors de variations extrêmes du volume cardiaque.	525. Faux
526.	Lorsque le volume cardiaque augmente de façon trop importante, le péricarde normal devient rigide.	526. Vrai
527.	Le volume du ventricule gauche est réduit à l'inspiration si le volume péricardique est fixe.	527. Vrai
528.	Le septum interventriculaire est déplacé vers la droite à l'inspiration pour augmenter le volume du VG.	528. Faux
529.	Le pouls paradoxal s'explique par l'interdépendance des volumes ventriculaires dans un péricarde rigide.	529. Vrai
530.	Le pouls paradoxal est caractérisée par une augmentation de la PA > 10mmHg à l'inspiration.	530. Faux
531.	80% des péricardites virales sont dus aux virus Coxsackie.	531. Faux
532.	Les bactéries et les champignons sont aussi capables de causer des péricardites aiguës.	532. Vrai

533.	La diminution du pouls à l'inspiration est un signe de tamponnade.	533. Vrai
534.	La pression artérielle est normalement réduite de moins de 10mmHg lors de l'inspiration.	534. Vrai
535.	La réduction de la PA à l'inspiration s'explique par une diminution du retour veineux à l'inspiration.	535. Faux
536.	Le pouls paradoxal est caractérisée par une diminution de la PA <10mmHg à l'inspiration.	536. Faux
537.	La péricardite aigue peut survenir dans le cadre d'une maladie auto-immune ou inflammatoire : lupus érythémateux, maladie de Crohn, arthrite rhumatoïde, maladie de Behçet, artérite de Horton, RAA,...	537. Vrai
538.	La radiothérapie et les médicaments (phénytoïne, isoniazide,...) sont des causes de péricardite aigue.	538. Vrai
539.	Le pouls paradoxal est caractérisée par une diminution de la PA >10cmH2O à l'inspiration.	539. Faux
540.	L'urémie et certains cancers peuvent provoquer une péricardite aigue.	540. Vrai
541.	La péricardite aigue se caractérise par une douleur sévère d'apparition progressive de type pleurale.	541. Faux
542.	La douleur de péricardite aigue est aggravé par les mouvements respiratoires, la toux et la position assise.	542. Faux
543.	La douleur de péricardite aigue est irradiée vers le dos et les omoplates.	543. Faux
544.	La péricardite aigue est souvent associée à un syndrome grippal et une fièvre modérée.	544. Vrai
545.	La douleur thoracique est réduite par la position penchée en avant en cas de péricardite aigue.	545. Vrai
546.	L'auscultation cardiaque révèle un frottement péricardique parasternal en cas de péricardite aigue.	546. Vrai

547. Le frottement péricardique est mieux audible si le patient est en décubitus dorsal.	547. Faux
548. Le frottement péricardique a 3 composantes : systole ventriculaire, proto-diastole et télé-diastole.	548. Vrai
549. L'ECG montre un sus-décalage diffus du segment ST sauf en aVF et V1 en cas de péricardite aigue.	549. Faux
550. L'ECG montre initialement une dépression du segment PR en cas de péricardite aigue.	550. Vrai
551. L'ECG montre un sus-décalage concave « en selle de cheval » du segment ST en cas de péricardite aigue.	551. Vrai
552. L'ECG se normalise quelques jours après une péricardite aigue.	552. Faux
553. Le segment ST redevient normal et l'onde T devient isoélectrique ou s'inverse après la phase initiale de la péricardite aigue.	553. Vrai
554. L'ECG montre un sous-décalage diffus du segment ST sauf en aVR et V1 en cas de péricardite aigue.	554. Faux
555. La biologie montre une élévation des enzymes myocardiques en cas de péricardite aigue.	555. Vrai
556. Une sérologie virale et HIV, des hémocultures et un test cutané à la tuberculine doivent être réalisés en cas de péricardite aigue.	556. Vrai
557. La radiographie de thorax est normale en cas de péricardite aigue.	557. Faux
558. La biologie doit doser plusieurs éléments en cas de péricardite aigue : créatinine, urée, T3, T4, facteur rhumatoïde, anticorps antinucléaires, signes de néoplasie hématologique,...	558. Faux

559.	L'échographie cardiaque permet de confirmer le diagnostic clinique de péricardite aigue.	559. Vrai
560.	La péricardiocentèse et la biopsie sont réservées aux péricardites sévères ne répondant pas au traitement.	560. Vrai
561.	La péricardiocentèse consiste à ponctionner le liquide péricardique à l'aide d'une aiguille.	561. Vrai
562.	La péricardite aigue répond souvent peu à l'aspirine et à l'ibuprofène.	562. Faux
563.	La colchicine augmente le risque de récidence de péricardite aigue.	563. Faux
564.	Les antibiotiques sont réservés aux péricardites purulentes.	564. Vrai
565.	On observe souvent une excellente réponse à l'aspirine ou à l'ibuprofène en cas de péricardite aigue.	565. Vrai
566.	Les corticoïdes comme la prednisolone sont utilisés dans le traitement de la péricardite aigue sévère.	566. Vrai
567.	Une anticoagulation par héparine ou antivitamine K est recommandée en cas de péricardite aigue.	567. Faux
568.	L'anticoagulation est réservée aux cas de péricardite associée à une ischémie ou un infarctus myocardique.	568. Vrai
569.	Les antivitamines K doivent être remplacés par de l'héparine chez les patients atteints de péricardite aigue avec une valve mécanique prothétique.	569. Vrai
570.	Les épanchements péricardiques néoplasiques sont toujours la conséquence d'une métastase.	570. Faux
571.	Les bénéfices du traitement anticoagulant sont inférieurs aux risques en cas de péricardite aigue.	571. Vrai
572.	La péricardite récurrente survient uniquement en cas d'échec du traitement initial.	572. Faux

573. La péricardite récurrente survient dans 20% des cas après une péricardite aigue.	573. Vrai
574. La corticothérapie chronique est recommandée en cas de péricardite récurrente.	574. Faux
575. La récurrence de péricardite nécessite la répétition du traitement par AINS, corticoïdes et colchicine.	575. Vrai
576. La péricardectomie est le traitement de choix pour les cas sévères de péricardite récurrente.	576. Faux
577. L'épanchement péricardique est souvent découvert par hasard à la radiographie de thorax.	577. Faux
578. L'épanchement péricardique est toujours induit par une réaction inflammatoire du péricarde.	578. Faux
579. L'IC, le syndrome néphrotique et l'hyperthyroïdie peuvent provoquer un épanchement péricardique.	579. Faux
580. L'épanchement est asymptomatique tant qu'il ne compromet pas l'hémodynamique cardiaque.	580. Vrai
581. L'alternance électrique est un signe typique d'épanchement péricardique à l'ECG.	581. Vrai
582. A l'ECG, le voltage du complexe QRS varie à chaque battement à cause des mouvements du cœur dans l'épanchement péricardique.	582. Vrai
583. La radio de thorax détecte un élargissement de la silhouette cardiaque si l'épanchement est de >400ml.	583. Faux
584. L'échographie cardiaque est l'examen le plus sensible pour détecter un épanchement péricardique.	584. Vrai
585. Le drainage péricardique peut être couplé à l'injection de tétracyclines ou d'antimitotiques pour tarir la sécrétion causant l'épanchement.	585. Vrai

586.	L'anticoagulation diminue le risque d'épanchement péricardique ou de tamponnade.	586. Faux
587.	Un cancer peut entrainer un épanchement péricardique par compression des lymphatiques médiastinaux.	587. Vrai
588.	La tamponnade est toujours une urgence médicale.	588. Vrai
589.	La tamponnade peut survenir suite à un épanchement brutal de 150ml.	589. Faux
590.	La tamponnade peut survenir suite à un épanchement très lentement progressif de 2L.	590. Vrai
591.	L'augmentation de pression péricardique comprime d'abord les cavités droites à basse pression.	591. Vrai
592.	Le débit cardiaque est augmenté en cas de tamponnade suite à la tachycardie réflexe.	592. Faux
593.	La tamponnade induit une tachycardie réflexe, une vasodilatation et une réduction du débit urinaire.	593. Faux
594.	Le patient atteint de tamponnade est souvent dyspnéique, tachypnéique et hypotendu.	594. Vrai
595.	La turgescence veineuse jugulaire est un signe de tamponnade.	595. Vrai
596.	Le pouls paradoxal est une exagération de la réduction expiratoire normale de la pression artérielle.	596. Faux
597.	La tamponnade est caractérisée par une augmentation des bruits cardiaques.	597. Faux
598.	Le flux mitral inspiratoire augmente de >25% à l'échographie cardiaque par rapport à la valeur expiratoire en cas de tamponnade.	598. Faux
599.	La péricardiotomie sous-xyphoïdienne chirurgicale est une option dans le traitement de la tamponnade.	599. Vrai

600. La péricardite constrictive survient surtout après une péricardite idiopathique ou une chirurgie cardiaque.	600. Vrai
601. La constriction péricardique se manifeste par une fibrose dense, des calcifications et des adhérences entre les 2 feuillets péricardiques.	601. Vrai
602. La fibrose ne s'étend jamais au ventricule en cas de constriction péricardique.	602. Faux
603. La tamponnade peut survenir suite à un épanchement péricardique brutal >200ml.	603. Vrai
604. Une hypothyroïdie peut entraîner un épanchement péricardique.	604. Vrai
605. La constriction péricardique augmente le débit cardiaque via une augmentation du rythme cardiaque.	605. Faux
606. La constriction péricardique se manifeste par un tableau d'insuffisance cardiaque gauche.	606. Faux
607. La fonction systolique ventriculaire est proche de la normale en cas de constriction péricardique.	607. Vrai
608. Le signe de Küssmaul correspond à une augmentation de la turgescence jugulaire à l'inspiration.	608. Vrai
609. Le pouls paradoxal est retrouvé chez 90% des patients atteints de constriction péricardique.	609. Faux
610. Les OMI, l'hépatomégalie et l'orthopnée sont des symptômes de constriction péricardique.	610. Vrai
611. L'auscultation cardiaque est normale en cas de constriction péricardique.	611. Faux
612. L'ECG montre un QRS de faible voltage et une altération de l'onde T en cas de constriction péricardique.	612. Vrai
613. La constriction péricardique entraîne souvent une hypertension pulmonaire.	613. Faux

614. Un B3 précoce est entendu à l'apex ou au bord sternal gauche en cas de constriction péricardique.	614. Vrai
615. Le B3 précoce correspond à un arrêt brutal du flux systolique en cas de constriction péricardique.	615. Faux
616. Le flux mitral expiratoire augmente de >25% à l'échographie cardiaque par rapport au flux inspiratoire en cas de constriction péricardique	616. Vrai
617. Le flux dans les veines pulmonaires est réduit lors de l'inspiration en cas de constriction péricardique.	617. Vrai
618. Les diurétiques sont contre-indiqués en cas de constriction péricardique.	618. Faux
619. La péricardectomie est une chirurgie risquée avec un taux de mortalité de 10%.	619. Vrai
620. La péricardite post-infarctus se manifeste quelques jours après un infarctus NSTEMI.	620. Faux
621. La péricardite post-infarctus est souvent localisée au niveau de la zone infarctée.	621. Vrai
622. Le syndrome de Dressler est une péricardite auto-immune qui survient après <1% des cas d'infarctus.	622. Faux
623. Le syndrome de Dressler atteint le myocarde de manière diffuse ainsi que la plèvre.	623. Faux
624. Le syndrome de Dressler est souvent accompagné de fièvre.	624. Vrai
625. L'hypertension artérielle pulmonaire est défini par une pression pulmonaire moyenne >5 mmHg au repos.	625. Faux
626. Le groupe 1 d'hypertension pulmonaire est caractérisé par des lésions des petites artéioles pulmonaires musculaires.	626. Vrai

627. Les infections par le VIH peuvent causer de l'hypertension pulmonaire dans environ 0,5 % des cas.	627. Vrai
628. L'hypertension portale est la première cause d'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1.	628. Faux
629. Les shunts gauche-droite congénitaux sont une cause d'hypertension pulmonaire du groupe 1.	629. Vrai
630. Le groupe 5 d'hypertension pulmonaire est secondaire à des mécanismes non élucidés ou multifactoriels.	630. Vrai
631. L'hypertension pulmonaire est définie par une pression pulmonaire moyenne >20 mmHg au repos.	631. Vrai
632. Les connectivites (lupus, sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde,...) sont la 2 ^{ème} cause d'HTAP du groupe 1.	632. Vrai
633. L'hypertension portale provoque une HTAP chez 25% des patients.	633. Faux
634. L'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 est rarement idiopathique et généralement consécutive à une affection cardiaque gauche ou pulmonaire.	634. Faux
635. 80% des cas d'HTAP ont une mutation dans le gène Bone Morphogenic Protein Receptor type 2.	635. Vrai
636. L'hypertension portale est la 3 ^{ème} cause d'HTAP du groupe 1 à cause d'une toxicité sérotoninérique.	636. Vrai
637. Les pathologies du cœur droit sont une cause très fréquente d'hypertension artérielle pulmonaire.	637. Faux
638. Les métamphétamines sont responsables d'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1.	638. Vrai
639. L'hypoxie chronique en altitude (>2500m) est un facteur favorisant d'HTP du groupe 3.	639. Vrai
640. L'asthme, l'emphysème et la fibrose pulmonaire idiopathique provoquent une HTP du groupe 3.	640. Faux

641. Les thrombo-embolies pulmonaires sont une cause d'HTP du groupe 4.	641. Vrai
642. La sarcoïdose, les leucémies et la drépanocytose peuvent provoquer une hypertension pulmonaire.	642. Vrai
643. Quel que soit l'étiologie, l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 est caractérisée par une prolifération des cellules endothéliales et une atrophie de la média.	643. Faux
644. Les artères pulmonaires ont une propension accrue à la vasoconstriction en cas d'HTP du groupe 3.	644. Faux
645. La synthèse de NO et de prostacycline est réduite en cas d'HTAP du groupe 1.	645. Vrai
646. Les taux de sérotonine sont abaissés en cas de d'HTAP du groupe 1.	646. Faux
647. L'HTAP du groupe 1 est caractérisée par une accumulation de protéines extra-cellulaires et une thrombose des veinules et des artérioles pulmonaires.	647. Vrai
648. Les shunts gauche-droite congénitaux augmentent le débit pulmonaire et les forces de cisaillement exercées sur les cellules musculaires lisses.	648. Faux
649. Les pathologies pulmonaires qui augmentent la taille de l'arbre vasculaire pulmonaire favorisent l'HTP.	649. Faux
650. L'hypertension pulmonaire peut être causée par une pathologie valvulaire gauche.	650. Vrai
651. L'hypoxie chronique induit une vasoconstriction artériolaire pulmonaire irréversible.	651. Faux
652. Les symptômes d'hypertension artérielle pulmonaire apparaissent dès le début de la maladie.	652. Faux

653. Les symptômes d'HTP sont souvent aspécifiques : dyspnée, douleur thoracique, asthénie,...	653. Vrai
654. L'hypertension pulmonaire avancée provoque un P2 claquant et un souffle de régurgitation tricuspide.	654. Vrai
655. L'hypertension artérielle pulmonaire n'est jamais héréditaire.	655. Faux
656. L'hypertension pulmonaire avancée entraîne des œdèmes pulmonaires, une turgescence jugulaire, des palpitations et des syncopes.	656. Faux
657. Le phénomène de Raynaud est caractérisé par un spasme artériolaire avec une pâleur et une cyanose cutanée intermittente.	657. Vrai
658. L'hypertrophie auriculaire droite est un signe typique à l'ECG de l'hypertension pulmonaire.	658. Vrai
659. L'hypertension pulmonaire provoque une dilatation des cavités cardiaques gauches.	659. Faux
660. La scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion permet de rechercher une embolie pulmonaire.	660. Vrai
661. L'échographie cardiaque est utilisée pour mesurer les pressions pulmonaires dans le diagnostic de l'HTP.	661. Vrai
662. Le cathétérisme cardiaque permet de déterminer les résistances pulmonaires et leur réversibilité en réponse à l'inhalation d'oxyde nitrique.	662. Vrai
663. La résonance magnétique est rarement utilisée dans le diagnostic de l'hypertension pulmonaire.	663. Faux
664. La gazométrie montre une hypoxémie en cas de shunt gauche-droite.	664. Faux

665. Les antagonistes calciques ont un effet favorable dans le traitement de l'HTAP de groupe 1.	665. Vrai
666. Les bêta-bloquants sont recommandés dans le traitement de l'HTAP de groupe 1.	666. Faux
667. L'oxygène nasal est inefficace pour améliorer la survie des patients atteints d'hypertension pulmonaire.	667. Vrai
668. Les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 comme le sildénafil ne sont pas utilisés dans le traitement de l'hypertension pulmonaire.	668. Faux
669. Les antagonistes de l'endothéline peuvent augmenter la distance de marche en cas d'HTP.	669. Vrai
670. La transplantation pulmonaire est un traitement courant pour l'hypertension pulmonaire du groupe 4.	670. Faux
671. L'ECG montre une onde P pointue en D2 et une déviation de l'axe du QRS en cas d'HTAP.	671. Vrai
672. La thromboendartériectomie chirurgicale est utilisée pour traiter l'hypertension pulmonaire du groupe 4.	672. Vrai
673. L'hypertension artérielle pulmonaire est caractérisée par une pression pulmonaire supérieure de >20mmHg par rapport la moyenne au repos.	673. Faux
674. Les infections par le VIH sont la principale cause d'hypertension pulmonaire du groupe 1.	674. Faux
675. Les thrombo-embolies pulmonaires sont une cause fréquente d'hypertension pulmonaire du groupe 2.	675. Faux
676. L'hypertrophie ventriculaire droite est un signe typique à l'ECG de l'hypertension pulmonaire.	676. Vrai
677. L'association d'inhibiteurs de la PDE5 et d'activateurs de la guanylate cyclase est contre-indiquée.	677. Vrai

678.	L'oxygénothérapie permet d'améliorer la survie des patients atteints d'hypertension pulmonaire.	678. Faux
679.	L'administration excessive de diurétiques est nocive pour les patients atteints d'hypertension pulmonaire.	679. Vrai
680.	La radiographie de thorax ne permet pas de visualiser une dilatation de l'artère pulmonaire.	680. Faux
681.	L'HTP est de bon pronostic si les résistances pulmonaires sont réduites par l'inhalation de NO.	681. Vrai
682.	Le test de tolérance à l'effort est contre-indiqué en cas d'hypertension artérielle pulmonaire.	682. Faux
683.	L'ergospirométrie permet de calculer la VO2 max pour envisager une transplantation pulmonaire.	683. Vrai
684.	L'époprosterol est une prostacycline intraveineuse utilisée dans le traitement de l'HTAP.	684. Vrai
685.	Les dérivés nitrés sublinguaux sont le traitement le plus efficace en cas d'HTAP.	685. Faux
686.	La PGI2 IV induit un phénomène de tolérance progressive nécessitant l'augmentation des doses.	686. Vrai
687.	L'arrêt brutal du traitement par PGI2 IV peut entraîner une hypertension pulmonaire fatale.	687. Vrai
688.	L'iloprost IV est utilisé comme traitement et pour évaluer la réversibilité de l'augmentation des résistances pulmonaires en cas d'hypertension artérielle pulmonaire.	688. Faux
689.	Les inhibiteurs de la PDE5 et les activateurs de la guanylate cyclase sont couramment associés dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.	689. Faux
690.	Tous les patients souffrant d'HTP de groupe 4 doivent être anti-coagulés par des antivitamines K.	690. Vrai

691. L'arrêt du traitement par prostacycline IV peut entraîner une hypertension pulmonaire sévère et brutale.	691. Vrai
692. Les agonistes de l'endothéline sont utilisés dans le traitement de l'hypertension pulmonaire.	692. Faux
693. L'endothéline induit une vasoconstriction via son récepteur Etb et une vasodilatation par la libération de NO et de prostacycline via son récepteur Eta.	693. Faux
694. L'angioplastie percutanée des artères pulmonaires est possible en cas d'HTP de groupe 4.	694. Vrai
695. Le riociguat est un activateur de la guanylate cyclase à action vasodilatatrice et antiproliférative.	695. Vrai
696. Les tumeurs cardiaques primitives sont plus fréquentes que les tumeurs cardiaques secondaires.	696. Faux
697. Les sarcomes cardiaques sont généralement bénins chez les enfants.	697. Faux
698. Le myxome est la tumeur du cœur la plus fréquente et représente 90% des tumeurs primitives cardiaques.	698. Faux
699. Les myxomes sont souvent situés dans l'oreillette droite dans la moitié des cas.	699. Faux
700. Les embolies sont une présentation clinique fréquente des myxomes cardiaques.	700. Vrai
701. Les tumeurs cardiaques peuvent provenir de métastases de cancers pulmonaires ou de mélanomes.	701. Vrai
702. Le traitement des tumeurs cardiaques est généralement limité à la chirurgie.	702. Faux
703. Les myxomes cardiaques peuvent provoquer une sténose mitrale (œdème pulmonaire et syncope).	703. Vrai
704. Les tumeurs secondaires cardiaques sont 4x plus fréquentes que les tumeurs primitives.	704. Vrai

705. Les tumeurs cardiaques secondaires proviennent rarement de métastases de cancers mammaires.	705. Faux
706. La chimiothérapie est utilisée dans le traitement des tumeurs cardiaques.	706. Vrai
707. Les tumeurs cardiaques primitives concernent uniquement le myocarde.	707. Faux
708. Les myxomes cardiaques peuvent se manifester par une augmentation de la vitesse de sédimentation.	708. Vrai
709. Les myxomes cardiaques peuvent induire de nombreux signes généraux : fièvre, perte de poids, anémie, hypogammaglobulinémie, hyperleucocytose,...	709. Faux
710. Les myxomes cardiaques sont souvent des tumeurs pédiculées situées près de la fosse ovale dans l'OG.	710. Vrai